ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

ステロイドをいつ使うか — 要約

解説「ステロイドをいつ使うか」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

症候群ごとに別の治療

指示には「どの症候群に対する投与か」を薬・量・期間とセットで書く

検査ではなく症候群と血行動態

コシントロピン負荷試験の結果は待たない

低用量で早く、短期は漸減せず止める

効かなくても増やさない。血糖・電解質・相互作用の監視を開始と同時に組む

2 使い分けの全体 — 推奨は「強い」から「使わない」まで反転する

詳しく

症候群	推奨と数字	標準のレジメン
重症市中肺炎	SCCM 2024で唯一の強い推奨（院内死亡RR 0.62）。ATS 2026は条件付き（NNT 17）。非重症には使わない	ヒドロコルチゾン200 mg/日の持続、4〜7日のあと漸減
敗血症性ショック	条件付き（短期死亡RR 0.93）	ヒドロコルチゾン200 mg/日
ARDS	条件付き（28日死亡RR 0.82）。発症14日を超えて始めない	デキサメタゾン20 mg/日×5日→10 mg/日×5日
COVID-19	酸素が要る患者だけ（人工呼吸中RR 0.64、酸素不要ではRR 1.19）	デキサメタゾン6 mg/日、最長10日
インフルエンザ肺炎	**使わない**（ICU死亡HR 1.32）	例外は難治性ショック・喘息／COPD増悪・副腎不全

- **低用量で早く**：超大量パルスは死亡を減らさず二次感染を増やした。非改善のCOVID-ARDSに高用量を足すと90日死亡35.8%→51%。効かないときは量ではなく診断を見直す

3 敗血症性ショック — 離脱を早める薬

詳しく

十分な輸液のあとも、ノルアドレナリンかアドレナリン0.25 μg/kg/分以上が4時間以上続けば始める（負荷試験は待たない）

▼

変わること

- ショックと人工呼吸からの離脱が約1日早まる（ADRENAL 3,658例）
- 7日のショック離脱RR 1.24（確実性高）

変わらないこと

- 90日死亡27.9%対28.8%。個別患者データメタ解析でもRR 0.93（0.82〜1.04）
- フルドロコルチゾン50 μgは難治例の選択肢にとどめる

▼

説明は「救命薬」ではなく「離脱を約1日早める薬」。ショックのない敗血症（HYPRESS）にはショックへの移行を防がないので使わない

4 その他の場面と、投与・監視

詳しく

- **抜管前**：高リスクでカフリークテスト不合格なら抜管の4時間以上前から（ストライダーRR 0.35、再挿管RR 0.32）。1時間前の単回では足りない
- **PCP**：HIV関連はプレドニゾン21日間が標準。非HIVは重症の低酸素に絞る。テンプレートを流用しない
- **間質性肺炎の急性増悪**：パルスは低用量に勝らず（院内死亡50.6%対47.0%）、シクロフォスファミドの上乗せは有害
- **入れ方**：ヒドロコルチゾンは持続静注で（ショック離脱RR 1.14、低K血症RR 0.67）。血糖を4〜6時間ごと（140〜180 mg/dL）、K 4.0以上、白血球の上振れ（5,000〜10,000/μL）を治療失敗と読まない
- **相互作用**：開始24時間以内に薬剤師と確認。強いCYP3A4阻害薬（ボリコナゾール・クラリスロマイシン）は曝露増、誘導薬（リファンピシン・フェニトイン）は無効化。マクロライドはアジスロマイシンに

5 止め方 — 量ではなく投与期間で決まる

詳しく

- **3〜4週未満**（ICUの大半・5〜10日）は漸減せずに止めてよい。「念のため」の漸減は総投与期間を延ばす
- **3〜4週超**は2相性に：原疾患が許す範囲で近生理量まで速く→HPA軸の回復を待ってゆっくり。朝のコルチゾール300 nmol/L超で中止
- **中止直後の説明のつかない低血圧**は副腎クリーゼとして先に治療：ヒドロコルチゾン100 mg静注→200 mg/日

- [ ] **インフルエンザ**の検査結果を見てから始める
- [ ] **重症CAP**で培養の結果を待たない
- [ ] **CAPA**と診断されてもルーチンに止めない
- [ ] **フレイルの高齢者**では長期の害も家族と共有する

出典：本編の主要文献（SCCM 2024 Focused Update CCM；ATS CAP 2026 AJRCCM；Khoshnam Rad Pneumonia 2026；ADRENAL・APROCCHSS NEJM 2018；Pirracchio NEJM Evid 2023；HYPRESS JAMA 2016 ほか）。「強い推奨」と根拠の質は別の軸で、ATS 2026の推奨のエビデンスの質はすべて「低」か「非常に低い」です。